HagaZiekenhuis

Borstvergroting

De wens naar grotere of stevigere borsten leeft bij velen: jaarlijks worden in Nederland meer dan 3000 borstvergrotende operaties uitgevoerd. Het is belangrijk dat u deze operatie zelf wil ondergaan en dat de borsten zijn uitgegroeid. De operatie wordt alleen uitgevoerd als u ouder dan 18 jaar bent. In deze folder leest u meer.

Vergroting met prothesen

De meest eenvoudige, effectieve en duurzame manier om borsten te vergroten, is met siliconenprothesen. Deze bestaan uit een buitenkant van siliconenrubber en binnenin siliconengel. Over het gebruik van siliconen bestaan veel misverstanden. Medisch wetenschappelijk onderzoek heeft echter nooit aangetoond dat siliconen een schadelijk effect hebben op de gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, waarvan vrijwel alle plastisch chirurgen in Nederland lid zijn, is van mening dat een borstvergroting met siliconen een verantwoorde medische ingreep is.

Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen van een borstvergroting goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico's. Uw arts bespreekt deze uitgebreid met u.

De levensduur van prothesen kan beperkt zijn. Het is echter pas nodig om opnieuw te opereren, als u klachten van de borsten krijgt.

Voorbereidingen thuis

- **Medicatie:** Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit aan uw arts, deze kunnen tijdelijk worden gestopt. Stop medicatie alleen in overleg met uw arts/ anesthesioloog.
- **Voeding:** Voor een goed wondherstel na de operatie helpt het als u vooraf een goede voedingstoestand en conditie heeft. Om dit te ondersteunen kunt u extra eiwitten eten en eventueel vitamine C1000 slikken. Hiermee kunt u 2 weken voor de operatie starten en tot 1 week na de operatie doorgaan.
- **Roken:** Stop minstens 6 weken voor én na de operatie met roken om wondgenezingsproblemen te voorkomen.
- **Praktisch:** Neem een pyjama mee met knoopsluiting voor het gemak bij wondverzorging. Regel hulp in huis voor de eerste weken na de operatie.
- **Nuchter zijn:** Volg de instructies over niet eten en drinken voorafgaand aan de operatie.

Voor de operatie

Op de dag van opname tekent de plastisch chirurg het 'operatiepatroon' met een viltstift op uw borsten. De operatie wordt uitgevoerd langs de afgetekende lijnen. Vóór en 3 maanden na de operatie worden medische foto's gemaakt voor in uw dossier

De operatie

De borstvergrotende operatie vindt vaak plaats in dagbehandeling. Dat betekent dat u in de meeste gevallen na de operatie op dezelfde dag naar huis kunt. De operatie duurt gemiddeld 1 tot 2 uur en wordt uitgevoerd onder algehele narcose. De prothesen worden meestal via een snede in de huidplooi onder de borst ingebracht. De prothesen worden tussen de borstklier en de borstspier geplaatst, of onder de borstspier direct op de ribben. De plastisch chirurg bespreekt vooraf met u wat voor u de meest geschikte methode is.

De wondjes worden gesloten met oplosbare hechtingen en soms worden daar pleisters overheen geplakt. Aan het einde van de operatie is het soms nodig om een wonddrain te plaatsen. Een wonddrain is een slangetje dat vocht en bloed in het wondgebied afvoert. Zo ontstaat er geen opeenhoping en wordt druk op de wond voorkomen.

Na de operatie

Na de operatie voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan en er kunnen zichtbare blauwe plekken zijn. Dit wordt binnen een paar dagen minder. U mag de voorgeschreven medicijnen tegen de pijn gebruiken.

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt alvast een controle-afspraak ingepland voor op de polikliniek Plastische chirurgie. Tijdens dit bezoek wordt de wond gecontroleerd en worden zo nodig de hechtknoopjes die uitsteken verwijderd.

Als u naar huis gaat met een wonddrain, ontvangt u een folder met meer informatie over de drain. De drain zal tijdens een afspraak op de polikliniek worden verwijderd. Na ongeveer drie maanden zullen uw borsten hun definitieve vorm hebben.

Adviezen na de operatie

- U heeft een stevige BH aangekregen. Deze BH draagt u gedurende 6 weken dag en nacht. Bij het douchen mag deze even uit en daarna een uurtje luchten. Het dragen van deze BH zorgt dat de borst goed wordt ondersteund waardoor u vaak minder last heeft van het litteken, wondvocht en de blauwe plek. Bovendien houdt het de prothese op de juiste plek en bevordert het dragen van de BH uw herstelproces.
- U heeft oplosbare hechtingen. De hechtpleisters laat u zitten tot aan de controle-afspraak op de polikliniek. Eventuele gazen mag u (indien nodig) vervangen voor schone.
- Houd de eerste 24 uur uw wonden droog. Daarna mag u douchen (zeep is toegestaan, goed naspoelen). De pleistertjes mogen nat worden.
- U mag gedurende 6 weken niet baden, zwemmen, naar de zonnebank of een sauna bezoeken. Beweeg de schouders en armen normaal, maar hef de eerste 2 weken de armen niet boven 90 graden in het schoudergewricht.
- Gedurende 2 weken mag u niet zwaarder tillen dan 5 kg
- Gedurende 6 weken mag u niet sporten en geen zwaar huishoudelijk werk verrichten (stofzuigen, ramen zemen, strijken of een boodschappentas tillen). Lichte activiteit zoals wandelen is toegestaan.

- Na 4 weken kunt u het litteken (indien goed hersteld) insmeren en masseren met een hydraterende crème of een olie.
- Autorijden en fietsen kan doorgaans weer na een week of 2 tot 4 als u voelt dat u verantwoord kunt rijden.
- Slaap gedurende 6 weken niet op de buik en 1 week niet op de zij.
  Het is belangrijk om uw litteken zo lang het rood is, niet bloot te stellen aan ultraviolet licht (zon of zonnebank). U kunt het litteken beschermen met een pleister of in een later stadium met een hoge zonnebrandfactor.
- Een mammografie (borstonderzoek) is na zes maanden toegestaan.
- Heeft u de drain meegekregen naar huis? Kijk dan ook in de folder 'Naar huis met een wonddrain (redondrain)'.

Het te verwachten resultaat

Na de operatie zijn de borsten groter en steviger, maar er zijn wel blijvende littekens. Hoe deze littekens eruit zullen zien verschilt per patiënt. Gedurende het eerste jaar kunnen deze verdikt, rood en gevoelig zijn en strak aanvoelen. Na een aantal maanden worden littekens in de meeste gevallen minder opvallend. Er kan helaas géén garantie gegeven worden voor een goed resultaat of voor symmetrie van de borsten. Het uiteindelijke resultaat kan soms tegenvallen door enige ongelijkheid van de borsten.

Denk ook aan de volgende punten:

- In een enkel geval is na minimaal een jaar een kleine correctie nodig om een optimaal resultaat te bereiken.
- Door pilgebruik, zwangerschap of gewichtsverandering kunnen de borsten van vorm veranderen.
- Een borstvergrotende operatie kan er soms voor zorgen dat borstvoeding geven niet meer mogelijk zijn.

Veiligheid van borstprotheses

Borstprotheses worden wereldwijd veel gebruikt en zijn over het algemeen veilig bevonden door de inspectie van volksgezondheid. Toch zijn er enkele zeer zeldzame gezondheidsrisico's waar u van op de hoogte moet zijn:

- **BIA-ALCL** (Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma) is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker die zich rondom een borstimplantaat kan ontwikkelen. Het risico is 1 op de 35.000 tot 1 op de 7.000 vrouwen die protheses dragen. Vrouwen met een borstprothese wordt geadviseerd alert te zijn op symptomen zoals een plotselinge, aanhoudende zwelling of een knobbeltje in de borst of oksel. BIA-ALCL is een goed geneesbare ziekte.
- **ASIA** (Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants) is een verzamelnaam voor zeldzame immuunreacties die soms in verband worden gebracht met lichaamsvreemde materialen, waaronder implantaten. Symptomen kunnen onder andere chronische vermoeidheid, spierpijn en gewrichtsklachten zijn. Het verband is echter zeer moeilijk aan te tonen.

Het is belangrijk om bij veranderingen of klachten contact op te nemen met uw arts. Uw behandelend team kan u helpen bij het monitoren van uw gezondheid en eventuele vragen beantwoorden.

Overige informatie vanuit de Nederlandse Vereniging voor de Plastische Chirurgie over (de veiligheid van) borstprotheses zal verstrekt worden door uw behandelaar.

Mogelijke complicaties

Na elke operatie, hoe zorgvuldig uitgevoerd ook, kunnen complicaties optreden. Voor deze operatie zijn dat:

- Een **allergische reactie** op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen.
- Een **verminderd gevoel** van de borst. Soms herstelt het gevoel zich geheel of gedeeltelijk. Infecties rondom de prothese.
- **Wondproblemen**, zoals het opengaan van de wond(en) of vertraagde wondgenezing. Zowel wondproblemen als infecties kunnen leiden tot verlies van de prothese.
- **Bloeduitstortingen** komen regelmatig voor na deze ingreep en zullen binnen een aantal weken afnemen.
- Bij een **nabloeding** merkt u dat de borst in korte tijd erg zwelt (en soms blauw wordt). In geval van een nabloeding moeten wij u opnieuw opereren om de bloeding te stelpen.
- **Littekens** die dik, strak of pijnlijk kunnen worden.
- **Diep veneuze trombose of longembolie**: Tijdens de operatie kan er een bloedpropje ontstaan in een van de aderen, die later kan losschieten.
- **Kapselvorming:** Rond een ingebrachte prothese wordt een bindweefselkapsel gevormd. Soms treedt in dit kapsel verharding op, waardoor de borst hard en pijnlijk is. Een harde en pijnlijke borst is te behandelen met behulp van capsulotomie.
- **Pijn** in de borststreek.

Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven, omdat het genezingsproces verschilt per individu.

Vrijwel elke borstprothese zal in de loop van de tijd wat slijten. Het is dus mogelijk dat deze op een gegeven moment door middel van een nieuwe operatie vervangen moet worden; dit is alleen nodig als er klachten optreden.

Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Dit kan voor u extra kosten met zich meebrengen.

Kosten

Over het algemeen wordt een borstvergrotende operatie niet vergoed door de zorgverzekeraar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wil een zorgverzekeraar de kosten dragen. De medisch adviseur van uw zorgverzekeraar beoordeelt of u voor vergoeding in aanmerking komt.

U kunt via het secretariaat van de polikliniek Plastische chirurgie een offerte aanvragen voor de borstvergroting. Ook kosten voor een eventuele prothesewissel in de toekomst komen voor uw eigen rekening. Op medische indicatie kan het verwijderen van protheses soms wel vergoed worden.

Vragen en contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische chirurgie.

- op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur,
- telefoon Den Haag: (070) 210 7760
- telefoon Zoetermeer: (079) 346 2804

Wanneer neemt u na de operatie contact op?

- Koorts (38.5° C of hoger) en/of niet lekker voelen.
- Plotselinge enorme zwelling van de borst of wondgebied.
- Roodheid van de huid rondom de wond.
- Veel nabloeden van de wond, opengaan van de wond of veel vochtlekkage.

Als één van bovenstaande symptomen zich voordoet, kunt u contact opnemen met de polikliniek van uw eigen ziekenhuislocatie: locatie Den Haag of locatie Zoetermeer.

Krijgt u bovenstaande klachten in het weekend, 's avonds of 's nachts, neem dan contact op met:
- de Spoedeisende Hulp (SEH) Den Haag tel: 070 – 210 20 60
- de Spoedeisende Hulp (SEH) Zoetermeer tel: 079 – 346 25 39

Meer lezen

Lees op de website van de Nederlandse Vereniging van de Plastische Chirurgie meer over borstprothesen:
https://nvpc.nl/app/uploads/2022/07/Informatiefolder-borstprothesechirurgie.pdf

---

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

140123122025